

AFMCP Chapter 2 — 매트릭스의 중심 한국어

정신적·감정적·영적 요소와 GOTOIT 임상 방법

IFM AFMCP 과정 | Dr. Joel Evans (IFM 의료 담당 이사) | 한국어 번역본

강의: 매트릭스의 중심 — GOTOIT 전 단계에 걸친 정신·감정·영적 요소의 적용

안녕하세요, 저는 IFM 의료 담당 이사 Dr. Joel Evans입니다. 오늘은 매트릭스의 중심, 즉 환자의 정신적·감정적·영적 문제가 GOTOIT 각 단계에 어떻게 관여하는지에 대한 저의 개인적 관점을 소개합니다.

먼저 용어를 정리하겠습니다. '정신적(mental)'이란 인지, 인식, 집중력, 기억력 등 개인의 인지 기능 상태를 말합니다. '감정적(emotional)'은 일시적이거나 지속적인 기분과 감정을 설명합니다. '영적(spiritual)'이란 자신보다 더 큰 무언가와 연결 정도, 또는 의미와 목적을 부여하는 것에 대한 개인의 사고, 감정, 실천, 신념을 의미합니다. 이 모든 정신적·감정적·영적 요소들은 다른 정신·감정·영적 요소뿐 아니라 다른 생리적 기능까지 조절할 수 있는 능력을 가집니다. 이것이 바로 이 요소들이 매트릭스의 중심에 위치한 이유입니다.

Gather(수집) 단계 — 통찰의 환경 만들기

수집 단계에서 핵심은 먼저 자신을 수집하는 것의 중요성을 인식하고 이를 무시하지 않는 것입니다. 어떻게 자신을 수집하느냐는 여러분에게 달려 있습니다. 숨 한 번을 깊이 쉬거나, '자, 시작해보자'같은 격려의 말을 스스로에게 건네거나, '이 환자에게 도움이 되게 해주소서'와 같은 짧은 기도도 좋습니다. 무엇을 하느냐보다 무언가를 한다는 것 자체가 중요합니다.

환자도 스스로를 수집할 수 있는 환경을 만드는 것도 중요합니다. 우리는 이것을 '통찰의 환경 만들기'라고 부릅니다. 환자의 정신적·감정적·영적 측면에 관심을 보이면 방문 전체에 걸쳐 따뜻하고 연결된 느낌이 스며듭니다. 대기실에는 차분한 색상, 음악, 그림, 시, 자연물 등을 배치하여 의료기관 방문에 흔히 따르는 스트레스를 줄이도록 설계하세요. 진찰실과 상담실도 마찬가지입니다.

환자가 스트레스 반응에서 벗어나면 자신의 이야기를 온전히 접근하고 스스로도 몰랐던 연결고리를 발견할 수 있습니다. 스트레스가 인지에 부정적인 영향을 미치고, 더 깊은 차원에서는 통찰력과 자기 인식을 차단한다는 것을 나중에 살펴볼 것입니다.

매트릭스의 중심 정보를 어떻게 수집할까요? 다른 노드와 마찬가지로 중요합니다. 저는 모든 신환 초진 시 이를 포함하고, 이후 방문에서는 필요에 따라 '어떻게 지내세요?'라고 물으며 시작합니다. 기분과 인지에 대한 많은 접수 설문지를 활용하고 항상 후속 질문을 합니다.

영성 평가는 어떤 전자의무기록 접수 양식에서도 본 적이 없습니다. 제가 가장 좋아하는 방법은 단순한 질문입니다: '영적으로 어떻게 지내세요?' 이 질문은 많은 의미 있는 반응을 이끌어냅니다. '그게 무슨 뜻인가요?' 또는 '저는 종교인이 아니는데요'라고 답하면, 영성이란 자연, 신, 우주 등 자신이 신성하다고 여기는 것과의 고유한 관계이며, 종교는 다른 사람들과 공유하는 규칙, 신념, 관습, 실천으로 그 관계를 정의하는 공식적인 방법이라고 설명합니다.

저는 항상 무엇이 그들에게 의미와 목적을 부여하는지도 묻습니다. 이 질문은 치료 계획을 수용하도록 동기를 부여하는 데 도움이 됩니다. '이 강황을 드시면 손자들과 놀 때 관절이 덜 아플 거예요'처럼 환자에게 중요한 것을 중심으로 치료 계획을 설명할 수 있기 때문입니다.

타임라인에는 출생 전 기간부터 시작합니다. '어머니가 임신 중이셨을 때나 임신 바로 전 어머니의 삶이 어땠는지 생각해볼 수 있나요?'라고 물어봅니다. 계획하지 않은 임신, 불임, 재정적·부부적 스트레스 등을 확인합니다. 임신 중 스트레스는 아동기와 성인기의 시상하부-뇌하수체-부신 반응 변화와 관련이 있으며, 현재 경험하는 짧은 인내심이나 불안의 원인일 수 있습니다.

환자가 자궁 안에서 사랑받았다고 느끼는지, 어머니가 삶의 사건들로 인해 산만했는지도 묻습니다. 간접흡연 노출은 임신 합병증뿐 아니라 아동기 ADHD, 행동 장애, 성인 여성의 과체중·비만과도 관련됩니다. 태아기 및 영아기 간접흡연 노출은 성인의 우울 및 우울한 기분으로 이어질 수 있습니다. 신체적·감정적 학대, 인종차별, 빈곤, 식품 불안정, 주거 불안정의 건강 영향도 잊지 마세요. 아동기 부정적 경험(ACE) 설문지를 기억하십시오.

Organize(정리) 단계 — 연결고리 식별하기

정리 단계에서는 매트릭스의 중심과 수정 가능한 생활방식 요인, 매트릭스 노드 간의 수많은 연결고리를 식별해야 합니다. 예를 들어, 장-뇌 연결(gut-brain connection): 우울 또는 우울한 기분은 장 이상균총(gut dysbiosis)과 장 누수(leaky gut)가 주요 원인이 되는 뇌의 염증으로 볼 수 있습니다. 이 관계는 양방향입니다. 불안하거나 우울한 사람들은 설탕과 글루텐이 많은 가공식품 등 건강에 해로운 식품을 선택하고, 폭식이나 심한 식사 제한을 하는 경향이 있습니다.

이러한 통찰은 매트릭스에 직접적인 언어로 기록합니다. 예를 들어 '스트레스로 인한 나쁜 식품 선택'은 동화 노드와 수정 가능한 생활방식 요인의 영양 섹션 모두에 기록합니다. 직장과 같은 스트레스 요인은 스트레스 항목에 넣습니다.

치료적 만남의 모든 것과 마찬가지로, 정리 단계는 환자와 공동으로 만들어집니다. 환자가 식별하는 연결고리는 우리가 식별하는 연결고리만큼이나 중요합니다. 저는 항상 환자에게 '왜 이 문제가 생겼다고 생각하세요?'라고 묻습니다. 예를 들어, '왜 암에 걸렸다고 생각하세요?'에 대한 답이 '내 결혼 때문'이라면, '정크푸드를 너무 많이 먹어서'라는 답과는 전혀 다른 방향으로 중재를 우선순위화하게 됩니다.

Tell(전달) 단계 — 이야기를 다시 전달하기

전달 단계는 치료적 만남에서 가장 강력한 부분일 수 있습니다. 제가 가장 좋아하는 단계입니다. ATMs를 매트릭스와 수정 가능한 생활방식 요인의 맥락에서 설명하는 것입니다. 수집 단계의 정신·감정·영적 요소를 환자가 부여한 우선순위와 개인화를 반영하는 방식으로 이야기 재전달에 포함시키는 것이 중요합니다.

예를 들어, 환자가 당뇨병의 가장 큰 원인이 스트레스라고 말하면, 스트레스를 받을 때 신경전달물질 변화로 고혈당 지수 식품을 선택하게 되고 죄책감과 수치심이 감소한다는 과학적 사실을 설명하면 매우 효과적입니다. 비건이 된 후 피로와 우울한 기분이 생긴 사람에게는 B12 수치가 그 연결고리를 설명해줍니다. 새 가구와 신선한 페인트로 가득 찬 새 사무실로 이사한 후 갑자기 아픈 환자도 있습니다. 환자들 스스로 만든 연결고리를 의학적 메커니즘으로 설명해주거나, 다른 의사들이 절대 해주지 않았던 연결고리를 만들어주는 것은 특별한 일입니다.

전달 단계의 최고 순간은 '그러면 이것이 이해가 되시나요?'라고 말했을 때 환자들이 '이렇게 이해받는 느낌은 처음이에요'라고 말하는 것입니다.

Order(순서), Initiate(시작), Track(추적) 단계

순서 단계에서는 정신·감정·영적 요소를 치료 계획에 통합합니다. 이 과정은 신뢰를 필요로 합니다. 환자는 삶의 가장 사적이고 친밀한 세부 사항을 논의할 만큼 충분한 신뢰가 있어야 합니다. 환자가 치료 계획의 공동 창작자라고 느끼도록 해야 합니다. '작게 시작하고 싶으세요, 아니면 한 번에 많은 것을 시도하고 싶으세요?'와 같이 묻는 것이 중요합니다. 이것이 변화의 단계(stages of change)입니다. 최고의 임상 팁은 환자가 원하는 방식에 주의를 기울이는 것입니다.

시작 단계에서는 신경과 전문의, 치료사, 코치, 성직자, 정신건강의학과 전문의 등 전체 협력 진료팀에 대한 의뢰를 자주 활용합니다. 환자에게 도움이 될 것 같은 사람이 누구지 묻습니다. 항상 환자가 압도당하지 않는 계획을 세우세요. 직원에게 검사 처방과 보충제 구매 같은 실무를 도와달라고 하세요.

추적 단계에서는 매트릭스의 다른 영역을 추적하는 것과 다르지 않습니다. 다만 질문은 민감하게 해야 합니다. '가스와 더부룩함은 어떠세요?'는 쉽지만, '정신과 상담 약속은 잡으셨나요?'는 민감하게 접근해야 합니다. 저는 문제 목록에 우울한 기분, 인지 저하 의심, 영적 연결 추구 등을 기재하고 이후 방문에서 확인합니다. 이것은 역동적인 과정이며, 환자의 정신·감정·영적 문제를 논의하는 것은 상상하지 못했던 방식으로 연결될 수 있게 해줍니다. 환자를 진정한 인간으로서 대하는 것은 특권이며, 저는 환자와 만날 때마다 이 선물을 결코 잊지 않습니다.